Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Enseignement de la 3ème année médecine
Unité d'Enseignement Intégrée 1
Sémiologie cardio-vasculaire

Signes fonctionnels cardiaques
les palpitations
toux et hémoptysie

Pr Ouail D. MD, MCA
Service de Médecine Interne
ouailouailbejaia@gmail.com

Palpitations

- Des sensations anormales et désagréables produites par les contractions cardiaques.
- A l'état normal, les contractions du cœur ne sont pas perçues;
- En cas de palpitation, chaque contraction entraîne une sensation de choc ou d'ébranlement thoracique à l'emplacement de la pointe du cœur

Interrogatoire

- La durée: seconde, minutes, heures
- Le caractère : permanant, paroxystique
- Les circonstances d'apparition : effort, repos
- Rythme : régulier, irrégulier
- Signes associés:
  - La dyspnée
  - La douleur thoracique
  - La syncope

Les palpitations physiologiques

- Induites par
  - Un effort violent inhabituel
  - Une forte émotion.
- Dans ces cas, l'augmentation de l'ondée systolique fait que la contraction cardiaque est plus ample et devient alors perceptible.

Les signes de gravité

- Antécédent de cardiopathie sous jacente ou post infarctus
- Antécédents d'Hypertension Artérielle
- Antécédents familiaux de mort subite avant 35 ans
- Pouls > 150 bpm
- Hypotension artérielle ou signes d'hypoperfusion périphérique
- Angor
- signes d'insuffisance cardiaque
- Troubles de la conscience

Les palpitations pathologiques

- Les palpitations provoquées :
  - Par l'effort, elles accompagnent la dyspnée d'effort.

Les palpitations pathologiques

- Les palpitations spontanées
  - Le plus souvent intermittentes et surviennent sans cause évidente.
  - On distingue :
    - Les palpitations d'apparition progressive
    - Les palpitations à début brusque.

Les palpitations à début progressif

- Rythme cardiaque régulier.
- La fréquence cardiaque est modérément accélérée
- Leur début est progressif et elles s'arrêtent lentement au bout de quelques minutes parfois plus.

Les palpitations à début progressif

- Les circonstances d'apparition sont :
  - Après un repas copieux,
    - Surtout accompagné de boissons abondantes;
    - Elles surviennent au bout de 4 heures,
    - Elles sont souvent accompagnées par des sensations de battements artériels, au niveau des tempes;

Les palpitations à début progressif

- Après prise d'excitants : tabac, alcool, café, thé ou de certains médicaments : aminophylline, extraits thyroïdiens;

Les palpitations à début progressif

- Sans aucun rapport avec les repas, l'alimentation, l'effort ou les drogues ; survenant à n'importe quel moment de la journée, elles se voient chez des sujets ayant un profil psychologique particulier : anxieux, soucieux, elles peuvent alors s'accompagner de précordialgies traduisant une névrose cardiaque.

Les palpitations à début brusque

- Elles sont le plus souvent en rapport avec un trouble du rythme cardiaque.
- Les extra-systoles
  - Asymptomatique
  - Symptomatique :
    - Sous forme de sensation d'arrêt fugitif du cœur qui correspond à la pause extra-systolique
    - Sous forme de palpitation sporadique à type de coup de bélier, d'ébranlement, de bondissement en rapport avec la contraction post-extra-systolique plus ample.

Les palpitations très rapides

- Crises de tachycardie.
- Elles sont à début brusque parfois ressenti par le malade comme un déclic.
- Elles sont très rapides,
  - La fréquence cardiaque est égale ou supérieure à 150 par minute.
  - Elles peuvent survenir sur un cœur sain; par crises plusieurs fois par année, c'est le cas de la tachycardie paroxystique de Bouveret, elles sont alors régulières.
  - Elles peuvent être irrégulières, anarchiques, elles sont alors le signe d'une cardiopathie, c'est le cas de la fibrillation auriculaire.

Palpitation selon le rythme



Palpitation selon le rythme

Rythme régulier

- Tachycardie sinusale
- Tachycardie de bouveret
- Flutter atrial
- Tachycardie ventriculaire

Rythme irrégulier

- Extrasystoles
- Fibrillation atriale

Palpitation avec rythme régulier

La tachycardie sinusale

- Stimulation du nœud sinusal
- Installation progressive
- Retour progressif à la normale
- Sans gravité

Palpitation avec rythme régulier **tachycardie sinusale**

Adaptative

Sur pathologie extracardiaque

- L'effort physique, émotion, excitants, hyperthyroidie
- Fièvre, anémie, hypovolémie, sepsis, hypoxie, hypotension
- Alcoolisme, sevrage alcoolique

Adaptative sur pathologie cardiaque

- L'insuffisance cardiaque (dyspnée)
- Embolie pulmonaire
- Épanchement péricardique

Palpitation avec rythme régulier
tachycardie de Bouveret

- La crise a un début brutal, sans facteur déclenchant.
- Le patient sent tout d'un coup son cœur "s'emballer",
- Le rythme cardiaque est régulier avec une fréquence allant de 180 à 240/min.
- La crise dure de quelques minutes à quelques heures
- s'accompagne fréquemment d'un malaise lipothymique.
- La fin, généralement brutale comme le début, est souvent suivie d'une crise polyurique.

Palpitation avec rythme régulier **tachycardie de Bouveret**

- Affection bénigne
- Naissant habituellement au niveau de la jonction auriculo-ventriculaire
- Tachycardie jonctionnelle
- En dehors de cardiopathie.
- Les crises de tachycardie de Bouveret ont une évolution variable au cours de la vie avec des récidives plus ou moins fréquentes

Palpitation avec rythme régulier
Flutter atrial

- Peut être asymptomatique
- Peut se compliquer d'insuffisance cardiaque
  - Une polypnée d’effort révélatrice
- La fréquence cardiaque est en règle parfaitement régulière à 150/mn
- Isolé ou complique assez souvent une cardiopathie
- L'évolution dépend de l'affection cardiaque causale

Palpitation avec rythme régulier
Tachycardie ventriculaire

- Cliniquement :
  - Palpitation
  - Dyspnée
  - Vertige
  - Une syncope
- Souvent associé à des signes de gravité:
  - Œdème pulmonaire
  - Choc cardiogénique

Palpitation avec rythme régulier
Tachycardie ventriculaire

- Auscultation : La tachycardie est régulière avec un rythme entre 120 et 200 par minute.
- Causes :
  - cardiopathie ischémique
  - Valvulopathie
  - Myocardite
  - Insuffisance cardiaque

Palpitation avec rythme irrégulier
Extrasystoles

- Battements prématurés dans le cycle cardiaque.
- Perçues ou non par le patient.
- Signes fonctionnels
  - Souvent des impressions d'a-coups thoraciques et/ou cervicaux,
  - Parfois de sensation d'arrêt transitoire du cœur (pause post extrasystolique) plus ou moins gênants.

Palpitation avec rythme irrégulier
Extrasystoles

- Interrogatoire précise
  - Les circonstances déclenchantes :
    - prise d'excitant,
    - repos ou effort.
- Les causes:
  - Cardiopathie sous jacente
  - Hyperthyroidie
  - dyskaliémie
  - Excitants
  - Electrocution

Palpitation avec rythme irrégulier
Fibrillation atriale

- Palpitations de survenue souvent brutale
- Impression d'emballement plus ou moins intermittent du cœur.
- L'accès peut s'accompagner de
  - Dyspnée ou d'angor,
  - Rarement de lipothymie.
- Elle peut également se révéler par
  - Une poussée d'insuffisance cardiaque
  - Une embolie artérielle.

Palpitation avec rythme irrégulier
Fibrillation atriale

- La fibrillation atriale peut être paroxystique et peut devenir permanente et être alors moins symptomatique.
- A l'auscultation, le rythme cardiaque est
  - Rapide
  - Irrégulier (***tachyarythmie***)
  - entre 110 et 170/mn

Palpitation avec rythme irrégulier
Fibrillation atriale

- Les causes
  - Les valvulopathies mitrales,
  - Les cardiomyopathies notamment ischémiques,
  - L'hypertension artérielle
  - L'hyperthyroïdie..

LA TOUX ET LES HEMOPTYSIES

La toux

- Partage les mêmes caractéristiques avec la toux respiratoire
- Aiguë récente, rarement chronique
- Un signe d'insuffisance cardiaque gauche.
- Survient à l'effort ou au décubitus
- Accompagnée d'une expectoration séreuse, mousseuse, rosée

Les hémoptysies

Même démarche sémiologique que celle de la sémiologie respiratoire

Causes cardiaques :

- Insuffisance cardiaque gauche
- Rétrécissement mitral
- Cardiopathie congénitale

Causes vasculaires :

- Embolie pulmonaire
- Rupture d'un anévrysme artério-veineux
- Anévrysme de l'aorte thoracique fissuré dans une bronche